

Benzodiazépines au long cours : un usage à limiter sans le diaboliser

 Quand les benzodiazépines ont été commercialisées il y a soixante ans, leurs bénéfices et leur sécurité ont été largement mis en avant. Ces médicaments très efficaces sur l'anxiété et les troubles du sommeil étaient en effet nettement moins dangereux que les barbituriques alors largement prescrits. Ils ont été présentés comme "la" solution permettant de limiter les risques de dépendance et de décès en cas de surdosage.

 Comme souvent avec les médicaments, on peut basculer de l'idéalisation à la diabolisation, si on met le projecteur d'abord sur les bénéfices, puis ensuite sur les risques.

 Comme tous les médicaments efficaces, les benzodiazépines ont aussi des risques. Le plus fréquent est la survenue d'un syndrome de sevrage en cas d'arrêt brutal ou trop rapide. La réapparition ou l'aggravation de symptômes anxieux ou de troubles du sommeil est un frein important à l'arrêt de ces traitements.

 Les campagnes visant à réduire la prescription de benzodiazépines ciblent surtout leur usage au long cours. Il faut clarifier plusieurs points sur les risques associés à un usage prolongé :

-  un syndrome de sevrage est très différent d'une addiction. Par ex. on peut avoir un syndrome de sevrage en arrêtant les β -bloquants, l'addiction aux β -bloquants n'existe pas !
-  le mésusage est rare, la très grande majorité des usagers prennent uniquement la dose prescrite, sans l'augmenter
-  les comportements addictifs (trouble de l'usage) existent, mais sont exceptionnels

 Les règles de prescription de courte durée sont très adaptées pour les personnes dont les symptômes anxieux ou les troubles du sommeil sont d'apparition récente et transitoires. La plupart des personnes concernées ne présentent pas de trouble psychiatrique, un arrêt rapide est donc la bonne stratégie.

 Les campagnes visant à limiter l'usage des benzodiazépines oublient souvent d'évoquer les situations où les bénéfices des benzodiazépines au long cours l'emportent sur les risques. C'est le cas de nombreuses personnes concernées par un trouble psychiatrique chronique, comme par ex. un trouble anxieux généralisé :

-  non ou insuffisamment amélioré par les autres psychotropes (antidépresseurs, régulateurs de l'humeur, etc.)
-  non ou insuffisamment amélioré par les psychothérapies (ou n'y ayant pas accès)
-  pour lequel les benzodiazépines permettent de diminuer les doses et les effets indésirables d'autres psychotropes (antipsychotiques par ex.), ou d'éviter leur usage.

 Les personnes avec un usage chronique de benzodiazépines n'ont pas être culpabilisées si c'est la condition qui leur permet d'atteindre un niveau de rétablissement satisfaisant. De la même manière qu'il n'y a pas à stigmatiser des personnes concernées par des douleurs chroniques qui nécessitent des médicaments antalgiques au long cours. Et ce, y compris si l'usage dure 20 ans !

Références

<https://doi.org/10.1001/jama.2020.22106>

<https://doi.org/10.4088/JCP.23com14959>

